2019 본과 3학년 학년말고사 산부인과

2019.11.21.오전 10시

95문제 중 95문제 복원

올해 본2시험 + 작년 연말고사 골고루 탔어요

<산과>

1. (야마) 환자가 치료받고자 하는 문제에 대해 시간 순으로 명시한 것. 어디가 아프고, onset, duration… 등등 언제 악화되고 언제 완화되는지 등등 알아보는 것과 관련된 사항은?

   A. Chief complaint

   B. Initial assessment

   C. Physical examination

   D. Present illness

   E. ROS

2. 배 아파서 옴. hcg 5000-6000? 90/60mmHg. Hb 8.5. 초음파랑 도플러 주어짐. 올바른 처치는?

   A. 복강경 수술

   B. 경과 관찰

   C. 입원해서 MTX 투여

   D. 1주일 후 초음파

3. 과거에 임신성 당뇨 있었던 비만 산모. 9주 정도. 다음 중 해야하는 것은?

   A. 100g OGTT

   B. 50g OGTT

   C. 경과 관찰

4. (야마) 정상 산모 BMI 23일때 다른 이상이 없을 경우 임신 중 적절한 체중증가량은?

   A. 5-9,1kg

   B. 7-11.5kg

   C. 11.5-16kg

   D. 12.5-18kg

5. (야마) 다음 중 틀린 것은?

   A. 가족 중 신경관 결손이 있으면 엽산을 4mg 복용하면 좋다.

   B. 카페인은 600mg 이하로 섭취하는 것이 좋다.

   C. 다태임신에서는 철을 60-100mg을 복용할 수 있다.

   D. 임신 시에는 총 1000mg의 철이 필요한데 이 중 500mg은 모체적혈구량을 증가시키는 데 사용된다.

   E. 비타민A는 10,000IU 이상 섭취했을 경우 선천성 기형의 위험이 증가하므로 주의해야 한다.

6. (야마) 임신 전 상담을 하러 온 여성. 10년 전 epilepsy로 valproic acid 먹고 있음. 다음 중 틀린 것은?

   A. 임신 3개월 전부터 매일 엽산 0.4mg/day를 먹어줘야 한다.

   B. 임신 1기 노출 시 기형 발생위험률 9.3% 증가한다.

   C. 임신 6개월 전부터 약 용량 조절이 필요하다.

   D. Valproic acid로 인한 신경관 결손이 2-3배 일어날 수 있으니 단일용제 최소용량을 사용해야 한다.

   E. Valproic acid나 phenytoin 보다는 carbamazepine으로 단일용제 처방을 하는 것이 좋다.

7. 수정 후 황체를 유지해주는 호르몬은?

   A. hCG

   B. LH

C. Progesterone

8. 마지막 월경일로부터 7주. 임신주수 가장 정확하게 측정하는 방법은?

A. CRL

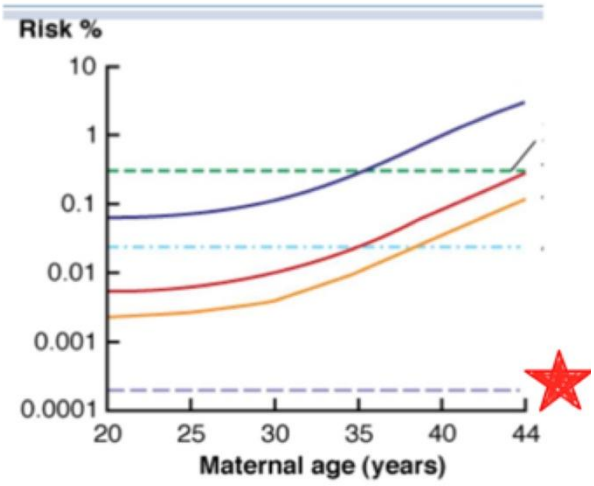
B. femur length

C. abdominal circumference

D. head circumference

E. BPD

9. (야마) 다음 별표에 해당하는 질환은 무엇인가?



A. trisomy 13

B. trisomy 18

C. trisomy 21

D. triploidy

E. 45X

10. (야마) 2-0-0-2 산모. 7일 전 제왕절개술로 분만하였다. 출산 4일 째에 퇴원하였다. 퇴원 당시 절개 부위는 깨끗하였다. 퇴원 후부터 열이 나기 시작하여 39도에 이르는 열이 반복적으로 났다. 오로에서 악취가 나고 자궁에 압통이 있었다. 초음파 소견과 가슴 x-ray 소견은 다음과 같다. 처치는?

A. 클린다마이신 + 젠타마이신 정주

B. 암피실린 + 젠타마이신

C. 진단적 복강경

D. 괴사조직제거

E. 상처 열어주고 secondary closure

11. (야마) 30세 산모가 질식분만하던 중 제왕절개로 정상아를 출산하였다. 분만 후 3일째부터 냄새나는 지 분비물과 함께 발열, 압통을 호소하였다. 체온은 38.2도, Hb 9.5, WBC 20,000이며, 자궁 저부는 배꼽주위에서 촉지되었다 다음 중 가장 가능성이 높은 질환은?

A. 급성 충수염

B. 급성 신우신염

C. 자궁내막염

D. 자궁부속기 감염

E. 창상 감염

12. (야마) 정상 질식분만한지 3주가 지난 모유 수유중인 여성의 왼쪽 유방에서 급격한 출혈과 함께 고열, 오한이 났다. 유방은 딱딱해지며 붉게 피부 변화가 있었다. 초음파 검사상 농양은 없었다. 피부 소견이 다음과 같을 때 해야 할 처치는?



A. 항생제 주입

B. 유방마사지

C. 절개 후 배농

D. 경과관찰

13. (야마) 진통억제제 중 다음과 같은 특성을 가지는 것은?

-칼슘길항작용

-과량 시 호흡부전

-태아 neuroprotective

A. Ritodrine

B. 황산마그네슘

C. Terbutaline

14. (야마) 다음 중 자궁 수축제로 쓰이지 않는 것은?

A. PGF 2alpha

B. Ketamin

C. Oxytocin

D. Ergonovine

E. Methylergonovine

15. (야마 early decel nst 사진주고) 원인은?

A. 태아두부압박

16. (야마 Prolonged decel nst 사진주고) 처치는?

A. 응급제왕절개

17. (변형) 1st trimester 산모 질출혈이 많았음. 임신낭은 보이지 않았고 종물이 남아있었다. 자궁경부 1-2cm 열려있었음. 치료는?

A. 소파술

B. 경과관찰

18. 1st trimester 산모. 4개월 전 임신중절 했음. 16주, 18주 유산 경험 있음.. 30% 소실. 1cm dilatation. 처치는?

A. Mcdonald

B. 맥로버츠

C. 옥시토신

19. 다음 초음파 사진과 같은 종류의 쌍둥이를 무엇이라 하는가?



A. Dichorionic diamniotic twins

B. Monochorionic diamniotic twins

C. Dichorionic monoamniotic twins

D. Monochorionic monoamniotic twins

20. 쌍둥이 37주 둘 다 두위. 산모가 원해서 자연분만 시작했고 한 명은 잘 나옴. 한 명이 10분동안 진행 없었고 HR 130 → 70까지 떨어짐.

A. 제왕절개

B. 옥시토신

C. 둔위로 변경해서 어쩌구

21. 임신 초기에 쌍둥이 진단할 때 가장 유용한 진단 방법은?

A. beta-hcg

B. 초음파

C. AFP

22. (야마) 25세 여성 33주 임신. 태동 감소를 주소로 내원. NST정상. 초음파 검사 상 예상되는 태아 무게 1900g(5백분위수 미만)-IUGR이라고 명시해줌. 양수지수 2cm 으로 보였다 태아는 두위, 전자 태아심박동수-자궁수축 감시장치 사진과 태아배꼽동맥도플러 사진이다(reversed diastolic wave). 다음 절차는?

A. 경과관찰

B. 양수주입술

C. 유도분만

D. 제왕절개술

E. 스테로이드 투여

23. (야마) 자궁의 윤곽 파악, 자궁 저부 촉진하고 자궁 옆면을 촉진하고 태아의 팔다리 방향 확인하고 자궁 하부를 촉진하고 골반 진입과 태세를 확인하는 것으로 양수과다증이 있는 경우 판단하기 어려운 수기는?

A. 레오포드 수기

B. 모리쉐 수기

C. 리트만 수기

D. 맥로버트 수기

24. (야마) 태아의 BPD가 골반 입구에 도달했을 때 태아의 하강도는?

A. -2

B. -1

C. 0

D. +1

E. +2

25. (야마) 임신 38주 35세인 산모가 진통으로 내원하였다. 자궁경부개대가 3cm, 자궁개대숙화가 50%, 아두하강정도 -2, 경부의 경도는 부드러웠으며, 경부의 위치는 anterior 이었다. Bishop score는 얼마인가?

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

E. 10

26. 임신 24주? 태동이 48시간동안 느껴지지 않아서 내원. 지금까지 문제 없었음. 초음파에서 태아의 심박동이 느껴지지 않을 때, 다음은?

A. Serial hcg test

B. Real time ultrasonography

C. NST

27. McRoberts maneuver 그림 보여주고, 발생 원인은?



A. T2DM

B. 양수과다증

C. 융모양막염

D. 미숙아

E. 전치태반

28. (야마) 첫째 아이를 제왕절개로 분만한 산모가 분만 진통으로 내원하였다. 산모는 찌르는 듯한 통증 이후에 계속되는 질출혈을 호소하였다. 가장 의심되는 진단명은?

A. 자궁파열

B. 잔류태반

C. 자궁내감염

D. 산도열상

E. 자궁이완증

29. (야마) 4200g의 아이를 성공적으로 질식분만하고 태반도 완전 만출되었으나 지속적인 질출혈이 있었다. 복부검사에서 배꼽 위가 물렁물렁하게 만져졌다. 다음 중 해야하는 처치로 옳은 것은?

A. 옥시토신

B. 긁어냄술

C. 베타메타손

D. 리토드린

E. 경과관찰

30. (야마) 임신 37주 산모가 4000g의 아이를 분만한 후 출혈이 지속되고 있다. 자궁은 배꼽 밑에서 단단하게 촉지되었으며 만출된 태반은 정상이었다. 가장 의심되는 것은?

A. 자궁목열상

B. 전치태반

C. 자궁무력증

D. 잔류태반

E. 자궁파열

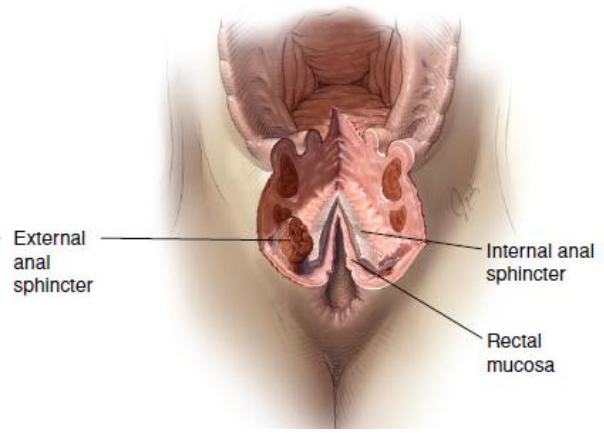
31. Placenta previa case. 산모 질출혈 있고 통증은 없음. 태아 심박은 정상이었으나 산모 vital 떨어짐.

A. 제왕절개

B. 유도분만

C. 경과 관찰

32. 회음부 열상 문제. 다음 그림 주고 grade는?



A. grade 4 perineal laceration

B. grade 3 perineal laceration

C. grade 2 perineal laceration

D. grade 1 perineal laceration

E. cervical laceration

33. (야마) 임신 36주인 산모가 심한 두통으로 내원하였다. 단백뇨 (3+/3+), 부종 (2+/2+), 혈압 190/100 이었다. 자궁목 확장과 숙화는 관찰되지 않았다. 처치는?

A. 유도분만

B. 경과관찰

C. 제왕절개

D. 칼슘 글루코네이트

E. 스테로이드

34. (야마) 과거 임신중독증이 있었던 환자가 내원했다. 임신 전 고혈압으로 nifedipine을 복용하고 있었다. 임신 28주였고, 약물로 120/80mmHg로 혈압관리를 잘 하고 있었다. 추가로 줄 수 있는 것은?

A. 저용량 아스피린 추가

B. 고용량 아스피린 추가

C. ACE inhibitor

35. (야마) 임신 중 고혈압에 대해서 옳지 않은 것은?

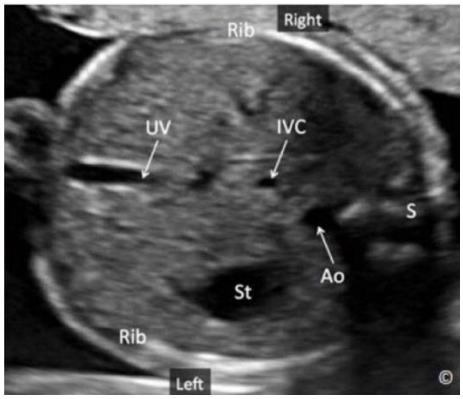
A. 산모의 혈압이 높은 경우 태반조기박리가 3배 증가한다

B. 혈관 내피의 파괴에 의해 혈소판과 피브린이 침착되어 hemolysis가 나타난다.

C. 저용량 아스피린을 추가하면 전자간증으로의 진행을 예방할 수 있다.

D. 혈압을 낮추기 위해 ACE inhibitor를 사용한다

36. (야마) 다음 사진은 fetal biometry 중 어느 부위를 측정하는 것인가? (한글보기였음)

37. 

A. HC

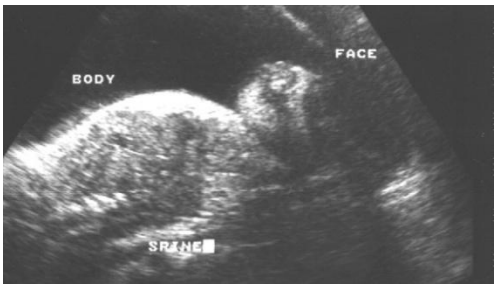
B. AC

C. FL

D. BPD

E. CRL

38. (야마) 초음파 사진 주고 진단은?



A. Anencephaly

B. Myelomeningocele

39. (야마) 다음 초음파 소견이 나타났을 경우 합병증은?



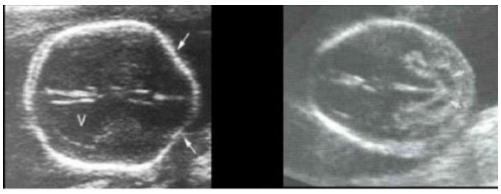
A. 식도 폐쇄

B. 요관 폐쇄

C. 양수과다증

D. 뇌막 탈출

40. (야마) 다음 소견을 보일 수 있는 것을 고르시오.



A. 신경관 결손

41. (야마) 산모가 피부발열, 열못견딤을 주소로 내원하였다. 안구돌출, 빈맥, 눈꺼풀 내림 지체가 있었다. 임신 전 체중은 52kg 이었는데 임신 후 53kg으로 증가하였다. 이 증상들은 임신 초기부터 지금까지 지속되었다. 이 환자의 진단을 위해 필요한 것은?

A. TRH

B. 갑상선자극항체

C. 갑상샘 미세소체 자가항체

D. Iodide

42. 산모 다리 부종. 초음파상 정맥확장소견과 혈전 확인됨. 처치는?

A. LMWH

B. 와파린

C. Urokinase

43. 산모 호흡곤란. 과거에 복부수술 받아서 장유착 심해서 수술시간 길어진 환자. 수혈도 받고 나왔는데 수술 2일후부터 숨이 차고 가슴이 아팠음. 처치는?

A. LMWH

B. 아스피린

C. 상체 거상

D. 호흡 보조 요법

44. 임신 25주에 50g OGTT, 100g OGTT 이상소견

으로 임신성 당뇨 진단. 식이요법과 운동요법 진행 후 4주 후 재검함. 해야할 것은?

	공복	식후2hr
날짜1	95	128
날짜2	107	150
날짜3	103	130
날짜4	110	170

A. 인슐린

B. 경구혈당강하제

C. 경과관찰

D. 운동을 더 한다.

<부인과>

45. (변형) Pure gonadal dysgenesis(Swyer syndrome)에 대한 설명으로 틀린 것은?

A. 46XY

B. Streak gonad

C. 외성기는 여성형이다.

D. 자궁이 있다.

E. 난소가 있다

46. (야마) 사춘기의 발달은 있으나 반대편 성의 소견을 보이는 Heterosexual pubertal development의 가장 흔한 원인은?

A. PCOS

B. Late-onset CAH (of 21-OH deficiency)

C. Cushing syndrome

D. Mixed gonadal dysgenesis

47. (야마) 여아 -> 남아, 환자에서 검사하는 항목이 아닌 것은?

A. SHBG

B. 17-OH Progesterone

C. Testosterone

D. DHEA-S

E. Estriol

48. 골다공증 케이스. 폐경증상 있었고 BMD -2.7. 고혈압, 당뇨 및 다른 기저질환 없었음.

A. 저용량 E+P

B. Calcitonin을 1차 약제로

C. Ca++ & 비타민D 보충

D. Teriparatide 먼저 쓰고 bisphosphonate로 변경

E. Denosumab 1차 약제로 사용

49. 골다공증 케이스. 폐경한 지 오래 됨. BMD -2.9~-3.5. 포사멕스 8년간 복용했음에도 이 상태. 최근에 척추 골절 있어서 입원. flush 등 폐경증상 없었음. 고혈압, 당뇨 및 다른 기저질환 없었음

A. 저용량 E+P

B. Denosumab 사용

C. Bisphosphonate 다른걸로 변경

D. Teriparatide 사용

E. SERM

50. 38세 여성. 4년째 임신 안됨. 부인은 정상. 남성 정자 : 1.00ml. OOO. OOO. 활동도 10-15% 정도. Morphology 4%. 불임을 치료하기 위한 시도로 옳은 것은?



A. 주기적으로 다시 시도

B. Intracytoplasmic sperm injection

C. IVF-ET

D. IUI

51. **사진 같이 나옴** 65세 여성, 1주일 전부터 소량의 질출혈 있고 질 입구가 쓰리고 따갑다며 병원에 내원하였다. 최근 성교통과 빈뇨가 생겼다고 한다. 이학적 소견 상 질 점막의 위축이 있었고, 소변 및 질분비물 검사와 자궁경부 액상세포검사는 정상이었다. 부인과초음파상 자궁내막 두께는 2mm 였다. 치료는?

A. 에스트로겐 질정

B. 클리트리마졸 연고

C. 경구 프로게스틴

D. 경구 메트로니다졸

E. 클린다마이신 크림

52. 다음 중 예방적 항생제 복용해야 하는 수술은?

A. 복강경 자궁절제술

B. 자궁내막 polyp 제거

C. 질후벽 봉합술

53. ** 절박 변형, 야마** 기침할 때 소변이 나와서 내원한 여성. Q tip 검사시 15도. 요역동근 검사상 방광근의 수축은 없지만 방광내압이 요도내압을 넘어설 때 소변이 샜다. 잔뇨량은 없었다. 진단은?

A. 범람요실금

B. 절박요실금

C. 복압요실금

D. 과민성방광

54. (야마) 개인병원에서 자궁적출술을 받은 환자가 응급실에 아파서 옴. 넣어준 수액 3000cc 나온오줌의 양 1000cc. 사진 2개. 원인이 되는 물질로 가능성이 가장 높은 것은?

A. 이산화탄소

B. Normal saline

C. Dextran 70

D. 3% sorbitol

E. 5.0% mannitol

55. (야마) 55세 여성이 성교 후 질출혈로 내원하였다. 생리 패드 10개 젖을만큼 많이 나왔다. 자궁 초음파 했을 때 내막두께 2.4cm. 해야할 것은?

A. conization

B. 자궁절제술

C. 자궁내막조직검사

D. CT

E. MRI

56. (야마. 복강경 수술 사진) ectopic pregnancy. 진단은?

A. 좌측 난관 임신

B. 좌측 자궁각 임신

C. 우측 난소 임신

D. 우측 난관 임신

E. 우측 자궁각 임신

57. (야마) 산과력 0-0-0-0인 40세 여자가 불규칙한 질출혈을 주소로 내원하였다. 내원 전날 저

녁부터 약간의 질출혈이 있었으나 내원 당시에는 멎었다고 하였으며, 활력징후는 안정적이었다. 이 상황에서 가장 먼저 시행해야할 검사는 무엇인가?

A. 혈청 프로게스테론 측정

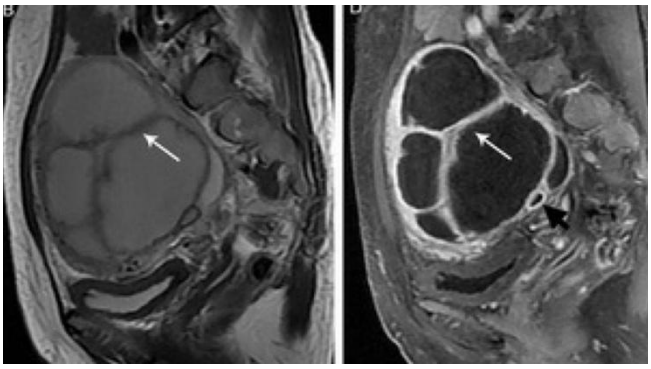
B. HSG

C. 자궁내막검사

D. 소변 beta-hCG

E. 자궁경검사

58. (야마) 산과력 2-1-0-2 28세 여자가 하복부 통증을 주소로 내원하였다. 신체 진찰 결과 cervical motion tendereness+였다. 다음은 환자의 MRI 소견이다. 필요한 처치는?



A. 입원하여 항생제 치료

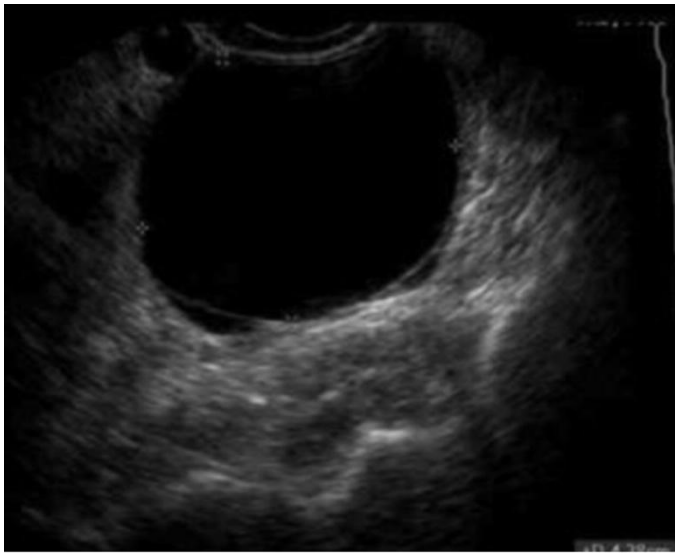
B. 경구피임제 투여

C. 시험적 개복술 혹은 복강경수술

D. 초음파 영상 하에 needle aspiration

E. 2개월 후 추적 관찰

59. (야마) 초음파 상 크기가 3.3cm인 속이 까만 병변이 보였다. 해아 할 처치는?



A. 2개월 후 추적관찰

B. 개복술

C. CA-125 추적

D. 입원하여 항생제 치료

E. 경구피임제 투여

60. 2개월 내 골반염 앓은 사람. 다음 중 사용하면 안되는 피임법은?

A. IUD

B. 경구피임약

C. 여성용 콘돔

D. 남성용 콘돔

E. 기초체온요법

61. KUB에 IUD가 fallopian tube 쪽으로 빠져있는 사진 줌.

A. 피임효과가 더 이상 없으니 다른 피임법을 권유한다.

B. 급성 충수돌기염이다.

C. 복강경 수술로 뺀다.

D. 안심시키고 귀가시킨다.

E. 항생제 사용

62. 임산부. IUD 실이 나와있었음.

A. IUD를 꺼낸다.

B. IUD를 놔둔다.

C. 치료적 유산을 한다.

D. MRI촬영을 한다.

63. (야마) 포상기태로 치료받은 환자의 피임법으로 알맞은 것은?

A. 자궁내장치

B. 복합경구피임제

C. 남성용콘돔

D. 여성용콘돔

64. (야마) 산과력이 1-0-0-1인 34세 여자가 정상분만하고 5개월 간 불규칙적인 질출혈이 지속되어서 내원하였다. 흉부 X선 촬영을 시행하였을 때 지름이 2cm인 전이성 종양이 발견되었고 당시 시행한 혈청 beta-hCG 농도는 100000이었다. 골반 초음파 검사에서 자궁 및 부속기에 특이적인 소견은 없었으며 뇌 자기공명영상 소견은 정상이었다. 자궁내막 조직검사에서 특이소견은 없었다. 이 환자에서 시행해야 할 조치는?

A. 면역요법

B. 단일 항암화학요법

C. 복합 항암화학요법

D. 자궁절제술 후 보전적 항암요법

65. 우측자궁부속기에 7cm mass 있었음. 해야할것은? invasive 어쩌구?

A. 추적관찰

B. suction & drainage

C. 단일 화학요법

D. 복합화학요법

E. hysterectomy

66. (야마) 산과력 1-0-1-1인 24세 여자가 질출혈로 내원하였다. 최종 월경일은 내원 2개월 전이었고 내진에서 자궁크기는 임신 13주에 해당되었다. 오른쪽 난소는 5x4x6크기로 커져있었다.초음파 결과는 다음과 같았고 혈청 beta-hCG 값은 100000이었다. 이 환자에서 가장 이상적인 처치법은 무엇인가?

A. 추적관찰

B. suction & drainage

C. 단일 화학요법

D. 복합화학요법

E. Hysterectomy

67. 성교통 월경통 있어서 내원. 초음파에서 endometrioma 보였음. 복강경 사진에서 fluid 고여있었고, 곧창자 유착된 소견. 진단은?

A. 곧창자유착부위와 난소 내막종

68. (야마) 45세 2-0-0-2 여성. 질출혈 많고 압박증상도 있고 잔뇨감 증상도 항상 있었다. pelvic MRI에 자궁근종 와방 많은 사진 줌. 치료는?

A. 전자궁적출술

B. 복강경하 자궁근종절제술

C. 자궁경하 자궁근종절제술

D. 경과관찰

E. 자궁동맥색전술

69. 27세 0-0-0-0 여성. 질출혈 많고 증상 있었음. Hb 7. 자궁근종 사진. 적당한 치료는?

A. 자궁절제술

B. 근종절제술

70. (CT사진주고) 골반내진을 하였는데 자궁내 septum 관찰됨. 이 진단명은?

A. Uterine Didelphys

B. Septate uterus

C. Bicorunate uterus

D. Unicornuate uterus

71. 바르톨린샘염 3회 있었던 사람. 여러번 항생제 쓰고 배농 했으나 다시 재발. 소음순 쪽에 3cm 종괴. 열감과 발적, 압통 있었음. 치료는?

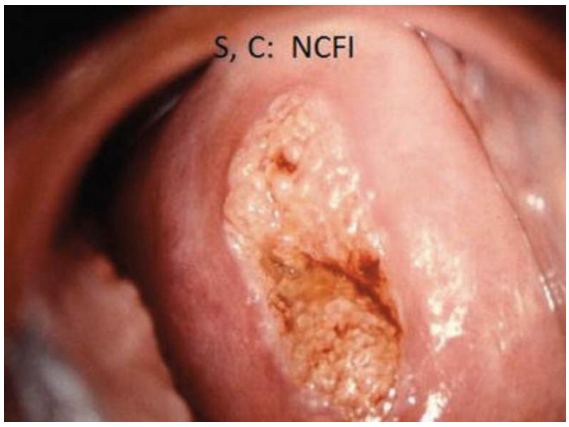
A. Marsupialization

B. 흡인

C. 항생제

D. 경과 관찰

72. Colposcopy에서 다음과 같은 소견을 보이면? (사진은 최대한 비슷한거 가져옴)



A. Necrosis

B. T-zone type 2

C. Dense acetowhite epithelium

D. Adequate

E. Irregular surface

73. 20대 여성이 세포진 검사 결과 LSIL, CIN1, HPV 저위험군 양성이 나왔다. 다음 단계는?

A. 경과관찰

B. Conization

C. 자궁절제

74. (야마) 산과력 3-0-4-3인 53세 여성이 성교 후 질출혈을 주소로 내원하였다. 개인 의원에서 실시한 자궁경부 세포 검사 결과 HSIL이 나왔다. 자궁 경부에 2cm 크기의 종괴가 관찰되었고, 질 확대경을 하자 자궁경부 조직검사를 시행한 생검에서 침윤성편평상피세포암으로 진단되었다. 수술 전 촬영한 MRI image는 다음과 같다. 다음으로 시행할 적절한 조치는?



(이렇게 큰 사진은 아니었어요)



A. 원추 절제술을 이미 시행했으므로 추가 치료 없이 정기적인 추적 관찰만 시행한다.

B. Simple hysterectomy

C. 다시 laser conization을 한다.

D. Modified radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection

E. Radical hysterectomy with pelvic lymph node dissection

75. (야마) 산과력 4-0-5-4인 64세 여성이 몇 달 전부터 시작된 우측 옆구리 통증과 우측 다리 부종을 주소로 내원하였다. 자궁경부 전체뿐만 아니라 양측 자궁조직까지 침윤된 자궁경부 편평상피세포암이 확인되었다. 응급실에서 찍

은 CT 소견은 다음과 같다. 환자의 적절한 치료법은? (비슷한 소견이 axial 사진으로)

A. 광범위 전자궁적출술 및 양측골반임파 절제술

B. 항암방사선 동시 요법

C. 전자궁적출술

D. 전자궁적출술 & 양측 난소난관 절제술

E. 면역요법

76. (야마) 자궁경부암 2mm 7mm. LVSI 없음. 임신을 더이상 원하지 않았을 때 치료방법은?

A. 단순자궁절제술

B. radical hysterectomy + LN dissection

77. (야마) 이전에 cervix에 국한된 cancer history로 인해 수술 후 퇴원했는데, f/u 중 남아있는 질에 squamous cell carcinoma 발견. 원격 전이나 LN전이는 없다. (이전에 방사선 치료를 받았다는 내용 적혀있지 않음) 어떤 치료를 해야 하는가?

A. 항암화학요법

B. 국소항암요법

C. 면역요법

D. 3개월 관찰

E. 방사선 치료

78. (야마) 67세 여성, 산과력 2-0-1-2, 질출혈을 주소로 내원하였다. Endometrial biopsy결과상 endometrial carcinoma였다. 검사 결과는 아래와 같다. 앞으로의 치료 방침은?

<검사>

Histology-endometrial carcinoma

FIGO stage 3

Tumor size- 1.4cm * 1.0cm

Myometrial invasion 10mm(전체 10mm)

Cervical involvement(-)

Pelvic LN(+)

Para-aortic LN(+)

Lymphovascular invasion(+)

Peritoneal cytology(-)

A. 복합항암방사선요법

B. Progesterone 호르몬 요법

C. 외골반 방사선 조사

D. 경과 관찰

E. 복합항암요법

79. (야마) 산과력이 0-0-1-0 32세 여성이 불임치료 중에 이상을 발견하여 내원하였다. 자궁내막 조직검사 결과 자궁 내막 암이었다. 162cm 82kg였다. 치료는?

<검사>

Histology-endometrial carcinoma

FIGO stage 1

Tumor size- 1.4cm * 1.0cm

High signal intensity

lesion LN invasion(-)

Myometrium invasion(-)

복강 내 장기 이상은 없었다.

A. -CCRT

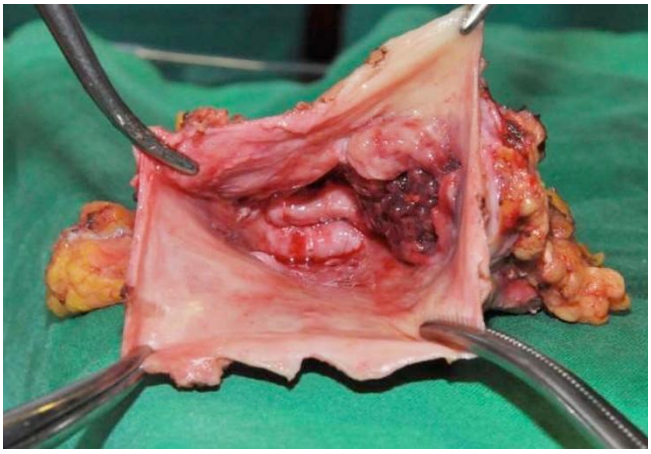
B. -Laparoscopic staging surgery

C. 국소 RT

D. 복합 CT

E. 고농도 progesterone

80. (변형) 다음 그림에 관해 틀린 것을 고르시오.



A. 상부 후벽에 흔히 발생한다.

B. 수술 후 방사선요법이 효과적이다.

C. 수술보다 항암요법이 효과가 더 좋다

D. PAP에서 잘 안 나오므로 시진이 중요하다

81. (야마) 다음 사진을 주고, 해야 할 검사는?



A. Keyes punch biopsy

B. 초음파

C. 자궁경

82. (야마) 다음 난소암의 병기를 설정하시오. 56세 여성 난소암 종양 감축술 받은 뒤 병리 검사 결과가 다음과 같다. Stage는?

Serous adenocarcinoma moderately differentiated

Right & left ovary둘다 침범

Capsule 침범

Washing cytology (+)

Pelvic LN mets (+) 7mm

Para aortic LN mets (-)

Omentum (+) omentectomy(+)

A. 1C1

B. IIIC1(ii)

C. IIIA1(i)

D. IIIB

83. (야마) 17세 여자 복부통증으로 응급실 왔을 때 AFP가 14000으로 높고 나머지 hCG, CA125, CA19-9는 낮았다. 진단은?

A. Endodermal sinus tumor

B. Dysgerminoma

C. Choriocarcinoma

D. Immature teratoma

84. (야마) uterine prolapse TVL=6cm. 처녀막부터 거리는 3cm. Stage는?

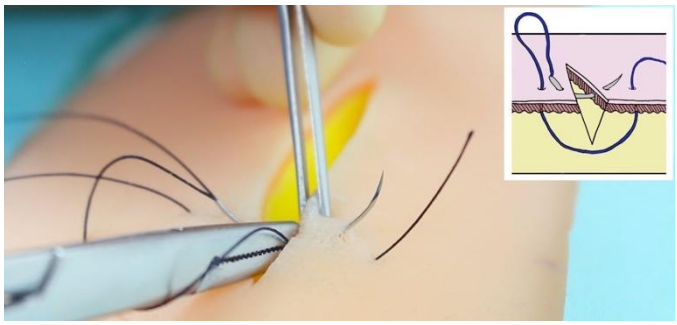
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

85. 유사한 사진 주고 어떤 suture인지 묻는 문제



A. Vertical mattress

86. Peripartum hysterectomy 적응증 옳지 않은 것은?

A. 자궁경부암 0기

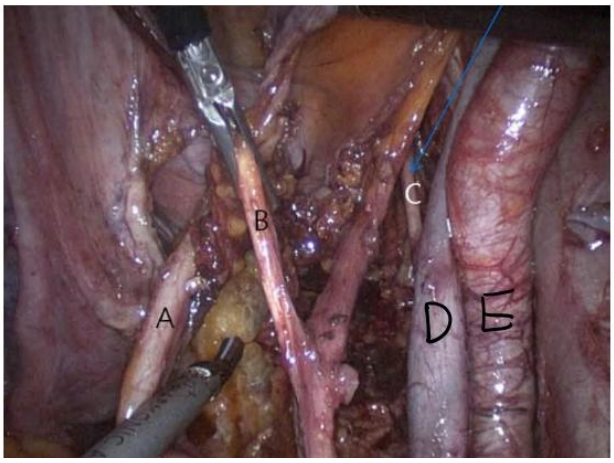
B. 영구적 피임방법

C. 산과적 출혈

D. 자궁혈관에 심한 열상?

E. 답 없음

87. (야마) ABCDE 순서대로 나열한 것은?



A. Right ureter – right uterine artery – right obturator nerve – right internal iliac vein – right internal iliac artery

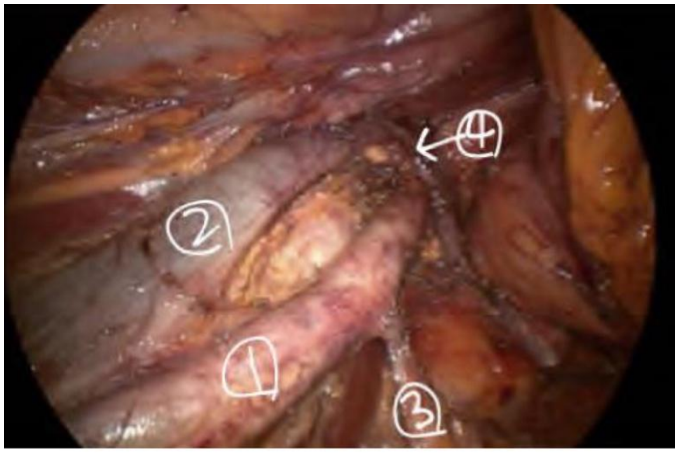
B. Right ureter – right uterine artery – right obturator nerve – right internal iliac artery

C. Left ureter – left uterine artery – left obturator nerve – left internal iliac vein – left internal iliac artery

D. Left ureter – left uterine artery – left obturator nerve – left internal iliac artery – left internal iliac vein

E. Right uterine artery – right ureter – right obturator nerve – right internal iliac vein – right internal iliac artery

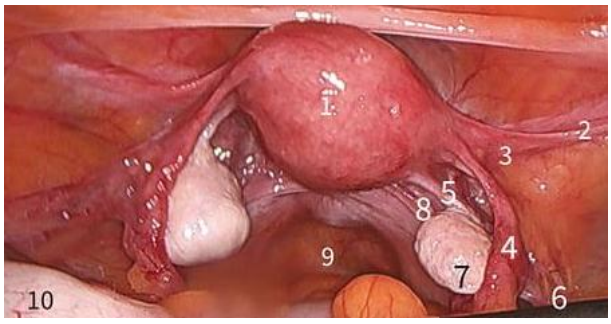
88. (야마) 다음 사진의 구조물을 번호 순으로 옳게 나열한 것은?



A. Abdominal aorta – inferior vena cava – left renal vein – inferior mesenteric artery

B. abdominal aorta – inferior vena cava – inferior mesenteric artery – left renal vein

89. 유사한 사진 주고 순서대로 된 것 고르기



A. Right round ligament, uterus, right ovarian ligament, right ovary, right IP ligament

90. 임신주수 12주 추정. 생리는 28일로 규칙적이다. 개인병원에서 nuchal translucency 3cm?가량 나와서 내원함. 옳지 않은 것은?

A. 부모 염색체검사 함께 시행

B. 초음파로 nuchal translucency 재검사

C. Nuchal translucency는 CRL 40mm?일 때 하기 때문에 초음파로 임신주수 정확히 측정

D. 15주에 triple? Quad? Test 해서 정상(2.0-2.5mom)인지 본다

91. (야마) NST에서 reactive이고, 30분 간 측정시 30초 이상 태아의 호흡이 지속되는 것이 2회였으며, 태아의 움직임은 30분동안 2회 관찰

되었다. 사지를 폈다가 구부리는 것은 관찰되지 않았으며, single vertical pocket의 크기가 2.5cm였다. BPP를 구하시오.

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

E. 10

92. (야마) 29세 임신 34주의 임산부가 병원에 내원하였다. BPP가 8점이었고 single vertical pocket=2cm이었다. 조치는?

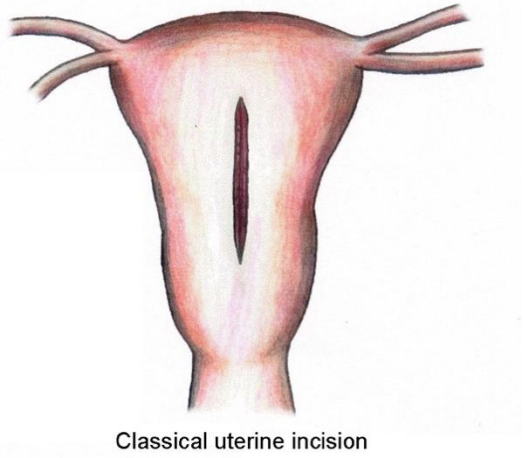
A. 1주 뒤 BPP 측정

B. 분만

C. 비수축검사

D. 응급제왕절개

93. 분만 임박한 산모. 과거에 제왕절개 했었음. 제왕절개 방법은 그림으로 보여줌. 조치는?



A. 제왕절개

B. 유도분만

94. 분만 임박한 산모. 과거에 제왕절개를 했었고, '고전적 절개법'으로 받았다고 알고 있음. 조치는?

A. 제왕절개

B. 유도분만

95. 여성 환자의 질경 검사 사진이다. 치료는?



A. Doxycycline

B. Ciprofloxacin

C. Acyclovir

D. Benzathine penicillin G